

CAPÍTULO 7.16

Insuficiencia Suprarrenal

PERFIL EUNACOM 1.03.3.002

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Síndrome de Cushing

Definición

- **Síndrome de Cushing:** exceso de cortisol de **cualquier causa**
- **Enfermedad de Cushing:** exceso de cortisol por **tumor hipofisario productor de ACTH** (la causa endógena más frecuente)

Causas

TABLA 7.16.1: CAUSA VS ACTH		
CAUSA	ACTH	CORTISOL
Exógena (corticoides iatrogénicos) — la más frecuente	↓	↑
Enfermedad de Cushing (adenoma hipofisario)	↑	↑
Síndrome de ACTH ectópica (Ca. pulmón células pequeñas)	↑↑↑	↑↑↑
Tumor suprarrenal (adenoma/carcinoma)	↓	↑

Clínica

TABLA 7.16.2: SIGNO VS DESCRIPCIÓN	
SIGNO	DESCRIPCIÓN
Obesidad central	Acumulación grasa en tronco, cara y dorso ("cara de luna llena", "giba de búfalo")
Estrías violáceas	> 1 cm, en abdomen, muslos, flancos
Hipertensión arterial	Efecto mineralocorticoide del cortisol
Hiperglicemia	Resistencia a insulina
Osteoporosis	Inhibición de osteoblastos
Miopatía proximal	Debilidad proximal de extremidades
Piel fina, equimosis	Catabolismo cutáneo
Amenorrea / disfunción sexual	
Acné, hirsutismo	(si hay ACTH ecto → más andrógenos)
Inmunosupresión	↑ infecciones

Diagnóstico en pasos

Paso 1: Confirmar hipercortisolismo

- **Cortisol libre en orina de 24h** ↑ - **Prueba de supresión con dexametasona** (1 mg nocturna) → cortisol matinal no suprime (normal < 1,8 mcg/dL) - Cortisol salival nocturno ↑

Paso 2: Determinar la causa

- **ACTH plasmático:** - ACTH ↓ → búsqueda de tumor suprarrenal → TAC o RNM suprarrenal - ACTH ↑ → causa hipofisaria o ectópica - **Si ACTH ↑ → test de dexametasona a altas dosis:** - Suprime →

enfermedad de Cushing (adenoma hipofisario) - No suprime → **ACTH ectópica** (tumor extrahipofisario) - **RNM hipofisaria** (pequeño adenoma)

Tratamiento

TABLA 7.16.3: CAUSA VS TRATAMIENTO	
CAUSA	TRATAMIENTO
Exógena	Reducir / suspender corticoides gradualmente
Enfermedad de Cushing	Cirugía del adenoma hipofisario (transesfenoidal)
ACTH ectópica	Tratar tumor primario + adrenalectomía bilateral si no resecable

| Tumor suprarrenal | **Adrenalectomía** |

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Hombre de 50 años con antecedente de vitiligo consulta por astenia severa, mareos ortostáticos, pérdida de 8 kg de peso y náuseas. Al examen: PA 90/55 mmHg con caída ortostática, hiperpigmentación marcada en pliegues palmares, cicatrices y mucosa bucal. Laboratorio: Sodio 128 mEq/L, Potasio 5.8 mEq/L, Glicemia 65 mg/dL. Cortisol basal 8 AM: 2.1 mcg/dL (muy bajo)."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Insuficiencia Suprarrenal Primaria (Enfermedad de Addison): destrucción autoinmune de la corteza suprarrenal con déficit de glucocorticoides y mineralocorticoides. Cursa con Hipotensión + Hiperkalemia + Hiponatremia + Hipoglicemia e Hiperpigmentación cutáneo-mucosa (por elevación compensatoria de ACTH y MSH). Diagnóstico: Cortisol basal 8 AM < 3-5 mcg/dL y Test de estimulación con ACTH sintética (Cosintropina). Tratamiento: Hidrocortisona (glucocorticoide) + Fludrocortisona (mineralocorticoide).

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Causa primaria más frecuente: adrenalitis autoinmune; clínica: astenia, síntomas GI, hiperpigmentación (solo primaria)
- Exámenes orientadores: hiperpotasemia + hiponatremia + hipoglicemia
- Diagnóstico: prueba de estimulación con ACTH (no confundir con supresión con dexametasona del Cushing)
- Primaria: ACTH alta + aldosterona baja; Secundaria: ACTH baja + aldosterona alta
- Tratamiento: hidrocortisona + fludrocortisona (solo si primaria); aumentar dosis ante estrés
- Crisis suprarrenal: shock que no responde a SF ni vasopresores; tratar con hidrocortisona IV ante la mera sospecha
- Síndrome de Waterhouse-Friderichsen: infarto hemorrágico bilateral de suprarrenales en meningococemia

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (INSUFICIENCIA SUPRARRENAL)

PREGUNTA 1

Mujer de 40 años consulta por astenia progresiva, náuseas, baja de peso y melanoplaquias en la mucosa oral. Laboratorio muestra potasio de 5.4 mEq/L, sodio de 131 mEq/L y glicemia de 62 mg/dL. ¿Cuál es el examen más apropiado para confirmar el diagnóstico?

- ☐ A) Prueba de supresión con dexametasona
- ☐ B) Prueba de estimulación con ACTH
- ☐ C) Cortisol urinario de 24 horas
- ☐ D) TAC de suprarrenales
- ☐ E) RMN de hipófisis

PREGUNTA 2

Paciente con insuficiencia suprarrenal confirmada. ACTH sérica elevada y aldosterona baja. ¿Cuál es el tratamiento más completo?

- ☐ A) Hidrocortisona sola
- ☐ B) Fludrocortisona sola
- ☐ C) Hidrocortisona más fludrocortisona
- ☐ D) Dexametasona
- ☐ E) Prednisona más espironolactona

PREGUNTA 3

Paciente de 55 años con antecedente de uso crónico de prednisona por artritis reumatoide llega a urgencia hipotenso (PA 60/40), taicárdico, que no responde a dos bolos de suero fisiológico. Potasio de 6.1 mEq/L, glicemia de 45 mg/dL. ¿Cuál es la conducta inmediata más apropiada?

- ☐ A) Iniciar noradrenalina
- ☐ B) Administrar hidrocortisona IV
- ☐ C) Solicitar prueba de estimulación con ACTH
- ☐ D) Administrar gluconato de calcio
- ☐ E) Realizar TAC de abdomen

RESUMEN: INSUFICIENCIA SUPRARRENAL

Clase sobre la insuficiencia suprarrenal, sus causas, clínica, diagnóstico y manejo, incluyendo la crisis suprarrenal. La causa más frecuente es suprarrenal (adrenalitis autoinmune, seguida de tuberculosa), y la segunda es hipofisaria (hipopituitarismo). La clínica incluye astenia (síntoma más frecuente), síntomas digestivos inespecíficos, e hiperpigmentación (solo en primaria, por aumento de ACTH y MSH). Los exámenes orientadores son hiperpotasemia, hiponatremia e hipoglicemia. El diagnóstico se confirma con la prueba de estimulación con ACTH (no confundir con la prueba de supresión con dexametasona del Cushing). Para diferenciar primaria de secundaria: ACTH alta y aldosterona baja = primaria; ACTH baja y aldosterona alta = secundaria (hipofisaria). El tratamiento es cortisol (hidrocortisona) más fludrocortisona si es primaria. Ante estrés, aumentar la dosis preventivamente. La crisis suprarrenal es una emergencia: shock que no responde a suero fisiológico. Se sospecha por hiperpotasemia, hiponatremia, hipoglicemia y antecedentes (corticoides crónicos, hiperpigmentación, hiperplasia suprarrenal congénita). Tratamiento: hidrocortisona IV ante la mera sospecha, sin esperar confirmación.